EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66250
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-06-20 13:32:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS ALBERTO VALLADARES LOPEZ			RUN	: 6.807.796-6
F.Nac	: 07-11-1950	Edad	: 72 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: Brasil 1201			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 21-04-2023	Fecha Egreso	: 2023-06-20 13:32:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D35.2-TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONÍA NOSOCOMÍA POR E. coli, POR USO DE VMI (HCHM)
TRAQUEOSTOMÍA POR VM Prolongada
PANSINUSITIS CRÓNICA
POSTRACIÓN POR ENCAMAMIENTO PROLONGADO.
LPP SACRA
TUMOR BENIGNO HIPOTÁLAMO, Resección parcial electiva en HCHM

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.1-NEUMONIA DEBIDA A PSEUDOMONAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J32-SINUSITIS CRONICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E03-OTRO HIPOTIROIDISMO. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. D35.2-TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. R26.3-INMOVILIDAD(POSTRADO EN: CAMA, SILLA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. Z93.0-TRAQUEOSTOMIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. N40-HIPERPLASIA DE LA PROSTATA. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Hospitalizado para Cirugía Electiva en HCHM por Tumoración Benigna del Hipotálamo. Se le realizó Tumorectomía parcial, descompresiva para aliviar Cefaleas. Cursó 2 días post-Operado en UCI HCHM, dado de alta a Sala General y luegto dado de alta y Controles en CAE Neurocirugía. El día de su alta se percataron que presentaba dificultad respiratoria, siendo evaluado por Medicina y trasladado a UCI por Neumonía Nosocomial por VMI, permaneciendo por más de 1 mes en UCI,
A su alta de UCI, sin camas disponibles en Sala general, se solicitó evaluación por Neurología para continuar tratamiento de Rehabilitiación y decidir si tratamiento sería ambulatorio u hospitalizado. Ante la falta de camas, se percataron que paciente pertenece a comuna de San Carlos, siendo trasladado a este Hospital, para continuasr rehabilitación Quinésica y Fonoaudiológica, con CUP, Traqueostomía y SNG de alimentación.
A su ingreso a HSC, se le asigno Administrativamente al Equipo de Cirugía que se hiciera cargo del pacienete.
Se le realizó estudios de TAC simple y con Contraste de Encéfalo y Cuello, para determinar el origen de su estado de conciencia deficitario. Se descartó complicaciones post-Operatorioas y se evidenció Pansinusitis crónica; cursando con Traqueobronquitis que fue tratada por Medicina con antibióticos por 7 días, luego de lo cual, paciente recupera estado de conciencia. Fue evaluado en CAE Neurocirugía, donde le dejaron indicaciones de seguimiento.
Posteriormente, hace 10 días, tuvo nueva Infección respiratoria baja que fue tratada por Medicina, cumpliendo tratamiento antibiótico hasta ayer.
Ha progresado mucho en terapia Fonoadudiológica: alimentándose en forma mixta por SNG y boca

Ha progresado mucho en Rehabilitación de marcha: se para con ayuda y continúa su terapia.
Realiza Terapia Ocupacional.
Se le retiró cánula de Traqueostomía.
Por su evolución, se decide continuar terapia de Rehabilitación Multidisciplinaria en Hospitalización domiciliaria.
Sin indicadiones por Cirugía ya que no es nuestreo paciente.

PLAN DE MANEJO:

Hospitalización Domiciliaria
CESFAM para tratamiento crónicos

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen mixto, según indicaciones de Fonoadiología.
3. Rehabilitación, seguón inidcaciones de Kinesiiólogos
4. Cuidados de Traqueostomía.
5. Tratamiento Crónicos por APS
6. Omeprazol 20 mg vo c/noche.
7. AAS 100 mg vo c/noche.
8. Atorvastatina 40 mg vo c/noche.
9. Aerosolterapia: Fenoterol, B. Ipratropio: 2 puff c/8h con Aerocámara
10. Enoxaparina 40 mg sc c/día.
11. Prevenir Lesiones por Presión
12. Tratamiento antidepresivo en APS
13. Seguimiento en CAE Neurología, ORL y Neurocirugía (HCHM)
14. NO requiere controles en CAE Cirugía.

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC simple y con Contraste de Encéfalo y cuello

Control en: 10 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

ERIC VALDIVIESO LOPEZ
MEDICO TRATANTE
14718240-6

JEFE SERVICIO